

103 年放射腫瘤科專科醫師甄審

考前題庫-GU

1. 下列有關腎細胞癌(Renal cell carcinoma)的相關治療敘述，何者有誤？

Renal stereotactic body radiotherapy(SBRT)能考慮作為 thermal ablation 的替代選擇，唯臨床文獻仍少
Adjuvant RT 並不建議在手術完整切除腫瘤(complete resection)後使用，因為存活率會下降，且副作用上升

2. 下列有關泌尿道腫瘤的分期敘述

膀胱癌侵犯攝護腺基質(prostate stroma)為 T4a

攝護腺癌術後發現有顯微侵犯膀胱頸部(microscopic invasion of bladder neck)為 pT3a

陰莖癌侵犯尿道為 T3

3. 下列有關 AUA/ASTRO 所提出針對攝護腺切除術後 adjuvant/salvage radiotherapy

單獨接受 radical prostatectomy 後，若病理報告顯示有 extraprostatic extension (EPE)、seminal vesicle invasion (SVI)、surgical margin positive，則五年復發率可能超過六成

Radical prostatectomy 後 PSA level 應該為 undetectable，若為 detectable 或數值上升且數值 ≥ 0.2 ng/mL，並再次確認(second confirmatory)數值 ≥ 0.2 ng/mL，則定義為 biochemical recurrence

4. 下列有關攝護腺癌 (Prostate cancer)的相關敘述

根據 prostate cancer outcomes study(PCOS)結果顯示

根據 prostate cancer prevention trial(PCPT)顯示

根據 NEJM 由 Maha Hussain 所發表之比較間歇式或連續式雄性素阻斷治療(intermittent versus continuous androgen deprivation)的研究結果顯示

5. 下列有關陰莖癌(Penile cancer)之描述

新生兒施行包皮環切術(circumcision)對預防陰莖癌發生有助益

在執行陰莖癌放射治療前，應施行包皮環切術

針對臨床上無淋巴結侵犯(clinically negative nodes)的患者

陰莖的 Bowen disease 常伴隨有內臟惡性腫瘤的發生

6. 有關尿道癌(Carcinoma of urethra)之描述

大部分的男性尿道癌發生於 bulbomembranous region，約佔六成，預後較發生於前部者佳

發生於攝護腺部尿道(prostatic urethra)的癌症，超過九成為移行上皮癌(transitional cell carcinoma)；

鱗狀上皮癌(squamous cell carcinoma)只發生於 bulbomembranous urethra

放射治療能達到器官保留的好處，因此為男性尿道癌主要的治療方式

7. 有關睪丸癌(Testicular cancer)之描述

最常被診斷出精母細胞瘤(seminoma)的年齡層介於 30 到 34 歲

睪丸未降(undescended testicle)與不孕(male infertility)皆為睪丸癌的危險因子

Intratubular germ cell neoplasia 約有一半的機會(50% risk)會在五年內進展成侵襲性生殖細胞瘤(invasive germ cell tumor)

Endodermal sinus tumor 患者的甲型胎兒蛋白(alpha-fetoprotein)指數會上升

8. 下列有關第一期精母細胞瘤(Stage I seminoma)之治療敘述

經 radical inguinal orchiectomy 後，可選擇的後續治療方式包括 surveillance、adjuvant radiotherapy
根據 Warde 的統合分析(meta-analysis)報告顯示，接受 surveillance 的這群患者，其五年復發率約為 15~20%

根據 MRC 比較術後放射線治療與術後化學治療(Carboplatin)的隨機分派研究顯示，兩組復發率相似

根據 MRC TE18 比較術後放射線治療劑量的隨機分派研究顯示，使用 30 Gy/20 fractions 或 20 Gy/10 fractions

9. 有關膀胱癌(Bladder cancer)之描述

在已發展國家中，最常見的膀胱癌組織型態為泌尿上皮癌(Urothelial carcinoma)，其與抽菸有關
超過七成的膀胱癌為非肌肉層侵襲癌(non-muscle invasive bladder cancer)，包括 Ta、CIS(carcinoma *in situ*)、T1，其中低危險群腫瘤(low risk tumors)為單一腫瘤、期別為 Ta 或 Tis、grade I、小於 3 公分
在研究膀胱致癌機轉(bladder tumorigenesis)，探討分子變異路徑(molecular alteration pathway)的相關文獻中發現，第九對染色體短臂上的缺失(deletions on chromosome 9p)常在移行上皮癌變早期被觀察到

10. 下列有關 BC2001 trial 及 BCON trial 之描述

BC2001 trial 為 2 x 2 的研究設計，第一個隨機分派為 radiotherapy with or without chemotherapy，第二個隨機分派為 whole bladder radiation versus modified volume radiation

BC2001 trial 所使用的同步化學治療藥物為 5-FU 與 mitomycin-C，而 BCON trial 所使用的放射增敏劑為 carbogen 與 nicotinamide

BC2001 trial 顯示使用同步化學治療並不會造成 grade 3 或 4 毒性的顯著增加($p = 0.07$)

11. 有關 BC2001 trial 的 patterns of failure 之描述

遠端轉移或二次癌症(second cancer)的比例大於局部復發(locoregional recurrence)

局部復發中，復發部位多在膀胱，其比例為骨盆腔淋巴結復發率的兩倍

高比例的二次癌症(second cancer)率，代表找尋更有效化學治療是未來重要的研究方向

12. 下列有關攝護腺癌(Prostate cancer)放射治療的劑量與範圍之相關研究敘述

根據 PROG 9509 study，把放射治療劑量由 70.2 GyE 提高到 79.2 GyE

根據 SWOG 8794 study，術後放射治療可增加 biochemical relapse-free survival 及整體存活率

根據 MDACC dose escalation trial，提高放射治療劑量能減少 10-year nodal failures、distant failures 及 death from prostate cancer

13. 下列有關 King 與 Ohri 所分別發表的兩篇探討 salvage radiotherapy(SRT)介入時機的系統性文獻回顧(systematic review)文章之描述

SRT 前的 PSA 數值與 relapse-free survival 有相關性

SRT 前的 PSA 數值與 5-year progression-free survival 有相關性

14. 有關攝護腺癌(Prostate cancer)預後因子之描述

D'Amico 針對 intermediate-risk group 的病患，依據 percentage of positive biopsy cores(PPC) >50% 及 ≤50% 作分層

針對接受 radical prostatectomy 的患者，high PPC 跟術後發現不良病理特徵有相關性

Hamstra 發表的統合分析(meta-analysis)發現

Zhou 發現接受 radical prostatectomy 或放射治療的病患，其 PSA doubling time(PSA-DT)